КСТ
КЛИНИКА
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ОСТАНОВИТЕ ПРОТЕЧКУ!

Самой распространенной урогинекологической проблемой, особенно в пожилом возрасте, сегодня признан синдром недержание мочи. Но большинство страдающих от этой неприятности стесняется обратиться к врачу, хотя доктор знает как с ней справиться. Поэтому мы решили пригласить читателей вестника на консультацию в Клинику современных технологий, специализирующуюся на женском здоровье. Корреспондент «ЗОЖ» Юлия Кириллова побывала на приеме у гинеколога Харичковой Алевтины Михайловны

«ЗОЖ».: Почему эта патология особенно актуальна для женщин?

А.М.: Женщины в силу анатомических особенностей организма сталкиваются чуть ли не в 2 раза чаще чем мужчины, с синдромом недержания мочи, преимущественно связанного с пролапсом (опущением) тазовых органов. Как правило, сбои начинают проявляться в самый уязвимый период - во время климакса, когда снижается выработка эстрогенов. Гормональная перестройка вызывает старение тканей, атрофию и истончение оболочек мочеполовых органов, мышц, связок тазового дна. У мужчин после 50 тоже меняется гормональный статус. Помимо ослабления мышц увеличивается предстательная железа, сжимающая

мочеиспускательный канал, и блокируется мочеточник. Отсюда затруднение опорожнения, учащенные походы в туалет. Это и многое другое способствует недержанию, которое скорее является не болезнью, а признаком патологических неполадок в мочевыделительной системе.

«ЗОЖ»: Непроизвольность, очевидно, главная особенность проявления синдрома?

А.И.: Формы недержания различаются по степени тяжести – от легкой, в виде нескольких капель, далее – средней обычно при небольшой физической нагрузке и до тяжелой в состоянии покоя. В норме транспортировку мочи обеспечивают мышцы тазового дна и мочевыводящий канал. Скапливающаяся жидкость растягивает пузырь и возникает позыв, который человек контролирует усилием воли, сжимая сфинктер мочевого пузыря. Во время опорожнения мышца, изгоняющая мочу, сокращается. И если давление в пузыре больше, чем в мочеиспускательном канале, то неизбежен прорыв. Это происходит из-за нарушения нервной регуляции мочевого пузыря при диабете, заболеваниях головного и спинного мозга, после операций на органах малого таза, лучевой терапии и из-за возрастных изменений мышц.

В основном различают недержание без позыва, то есть непроизвольное выделение мочи, и не удержание, когда невозможно дотерпеть, пока добежишь до туалета. Отклонения от нормы бывают связаны с опущением тазовых органов, стенок влагалища и патологической подвижностью шейки мочевого пузыря. Из-за психо-эмоционального напряжения, вроде

неожиданного испуга, резко подскакивающее внутрибрюшное давление передается на мочевой пузырь и выводящие пути. Сфинктер не в силах сопротивляться напору мочи, и она выдавливается, подтекает. Такой же стрессовый характер приобретает неконтролируемая течь при физической нагрузке, кашле, смехе, чихании, половом контакте. Иногда спонтанные внезапные сокращения «заслонки» (детрузора) в сочетании с неприятными ощущениями в промежности вызывают камни или опухоль мочевого пузыря. Бывает еще, так называемое, ложное недержание - не связанная с физическими нагрузками постоянная протечка, которая обусловлена наличием свища.

«ЗОЖ»: Расскажите о главных виновниках, провоцирующих беды с опорожнением.

А.И.: Я уже назвала некоторые из них. Уролог или уро-гинеколог определят, где и как нарушена моче проводная система организма с помощью комплексной диагностики. В нее включают стресс-тесты, анализы крови и мочи для выявления инфекции, УЗИ почек и мочевого пузыря, обследование органов брюшной полости и половых органов. Специальная уродинамическая проверка (урофлоуметрия, цистометрия и профилометрия) позволяют определить состояние полости мочевого пузыря, устьев мочеточника, наличие аномалий, опухолей. Сбои часто обязаны инфицированию мочеполовой системы кишечной палочкой, стрептококком, энтерококкоком, протеем. При определенных условиях безобидные микробы превращаются в опасных возбудителей болезней, которые при малейших воспалениях,

повреждениях тканей поднимаются вверх, завоевывая и заражая новые территории. У женщин с истонченной в постклимактерический период слизистой, из-за снижения уровня эстрогенов, да еще при наличии широкой и короткой уретры - препятствий распространению инфекции нет. Начинается цистит (воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря). Нарушения оттока и неполного опорожнения мочевого пузыря приводят к забросу зараженной мочи в мочеточники и восходящей инфекции почек. В итоге - острое гнойное воспаление, требующее операции, или чреватый инвалидностью пиелонефрит (воспаление почек). У мужчин – сходная ситуация – болезненное мочеиспускание, частые и ложные позывы, неприятный запах мочи. В период, так называемого "мужского климакса", функциональная активность простаты меняется. По мере увеличения размеров аденомы сужается просвет уретры, учащенное мочеиспускание сменяется затруднением. Не полностью опорожненный пузырь растягивается, а мышца «усыхает». Наиболее тяжелая стадия - когда из переполненного пузыря непроизвольно сочится моча, возникает почечная и сердечно-легочная недостаточность.

«ЗОЖ»: Каковы пути преодоления патологии?



А.И.: Самый современный способ лечения синдрома недержания мочи у женщин - использование лазерных технологий с помощью карбоновых CO 2 лазерных систем.

Процедура безболезненная, не требует применения анестезии, Это безопасный метод, не имеющий осложнений. Процедура длится менее 30 минут, курс – 2-3 сеанса с месячным перерывом. Но противопоказания есть – беременность, вирусные заболевания, сахарный диабет, выпадение тазовых органов, опухоли.

При стрессовом характере самопроизвольного недержания стали популярными и слинговые (петлевые) операции, когда под среднюю часть мочеиспускательного канала на полчаса помещается петлевая опора. Таково новое слово в лечении урогинекологических заболеваний.

Хотя в наши дни благодаря высокой эффективности и малой травматичности хирургические способы получили довольно широкое распространение, консервативное лечение не потеряло своей актуальности. Оно наиболее успешно в борьбе с самыми

распространенными причинами недержания - с нарушениями в нервной системе, регулирующей мочеиспускание.

«ЗОЖ»: Что же делать, если физиологическая потребность не поддается волевому усилию?

А.И. Прежде всего, стоит проконсультироваться с урологом, гинекологом. Врач пропишет препараты, подавляющие непроизвольное сокращение и расслабляющие мышцы сфинктера– ***детрузитол, спазмекс, дриптан***. ***Канефрон*** на основе травы золототысячника, корней любистока лекарственного, листьев розмарина не имеет противопоказаний. Обычный курс 14 дней трижды в день после еды по 2 таблетки (или по 50 капель), запивая водой или соком. Канефрон обладает мочегонными свойствами, расслабляет гладкую мускулатуру, снимая спазм и воспаление, уничтожает патогенную микрофлору. Он выводит соли и растворяет мелкие конкременты в мочеиспускательном канале.

При нейрогенном характере недержания иногда назначают антидепрессанты (***амитриптилин, имипрамин***), расслабляющие мочевой пузырь. Для уменьшения возрастных атрофических изменений слизистой оболочки полезны эстрогены: свечи ***овестин,*** пластырь ***клемара,*** гель ***дивигель.*** Но помимо медикаментозного лечения нарушений оттока используют физиотерапию (электромиостимуляцию и электрофорез) динамические и гальванические токи стимулируют и укрепляют мышцы сфинктера и тазового дна. Чтобы установить принудительный ритм опорожнения и контроль над удержанием мочи нужна тренировка мочевого пузыря. Врач поможет пациенту составить план

постепенного увеличения промежутков между походами в туалет: не дожидаясь позыва, посещать его сначала через 1-2 часа, затем паузу продляют. Прием основан на врожденной способности человека сокращать сфинктер заднего прохода, при котором сами собой расслабляются мышцы мочевого пузыря, и позыв уменьшается. Такая тренировка полезна практически всем больным с расстройством мочеиспускания.

Поскольку недержание у женщин бывает связано с опущением половых органов, помимо лечения этой патологии следует ограничить подъем тяжестей до 2-3 кг и ежедневно заниматься интимной гимнастикой, делая до 100 раз упражнения по укреплению мышц. Вырабатывая новый навык, рекомендуется практиковать попеременное быстрое и медленное сжатие, напряжение и расслабление ануса и влагалища (5 подходов по 20 раз).Надо научиться сокращать исключительно мышцы промежности без участия мышц бедра, ягодиц, брюшной стенки и наружного сфинктера (например, прерывая струю во время обычного мочеиспускания). Сжатые мышцы и влагалище удерживают, втянув задний проход 15-20 сек. А затем повторяют упражнение резко и быстро, сокращая мышцы на 1-2 сек. Так постепенно восстанавливается способность тазовых мышц самопроизвольно сжиматься в ответ на резкое повышение внутрибрюшного давления. Начинать занятия лучше в положении сидя, через 3-4 недели - стоя, а затем и при ходьбе.

«ЗОЖ»: А какие травы помогают остановить протечку ?

А.И.: В народной медицине издавна с успехом применяют самые разнообразные сборы. Бактерии погибают в кислой среде, поэтому при воспалениях полезно, например, пить заваренный кипятком в термосе чай из смеси золототысячника зонтичного и травы зверобоя (1:1), либо кукурузных столбиков с рыльцами (Можно с медом). Годятся и 10-часовой настой измельченных корней алтея (6 г), залитых стаканом кипяченой воды, холодные отвары из коры калины, вяза, ясеня. В качестве дневной порции чая подойдет и выдержанный 10 минут на слабом огне отвар смеси листьев и ягод брусники с травой зверобоя (по 2 ст. ложки на 3 стакана кипятка), а для разового приема - 2-3 часовой настой семян укропа (1 ст. ложка на стакан кипятка).

Вот еще рецепты:

*Заварить 1 л кипятка 1 ст. ложку смеси из листьев березы, толокнянки, кукурузных рылец, корня солодки (1:1). Пить по 1/3 стакана трижды в день до еды.

*Заварить стаканом кипятка 1 ст. ложку сбора из семян петрушки, трав хвоща полевого и вереска, шишки хмеля, корень любистока, створки плодов фасоли (2:2::1:1:1). Выпить глотками в течение дня при ночном недержании мочи.

Беседу провела Юлия Кириллова